



Consultation Playbook

Система проведения Patient Flow Check и Мини-Карты потерь для превращения интереса стоматологии в оплату Карты, Fix или Growth.

Документ для продаж, собственника, диагноста и любого сотрудника, который проводит встречу с клиникой.

Версия 1.0 | Patient Flow System | ШАРiK digital OS

00 / Суть playbook

Встреча ШАРiK digital - не бесплатная консультация и не презентация агентства. Это диагностическая продажа через Patient Flow Check: мы показываем владельцу стоматологии 3-5 мест, где пациент может теряться до записи, лечения или возврата, и переводим разговор в платный следующий шаг.

Главная ошибка - на встрече отдать весь план бесплатно. Главная задача - доказать экспертность, показать масштаб проблемы и открыть путь к Карте потерь, Fix или 90-дневному Growth.

Что продаём на встрече

Не услуги и не набор задач. Мы продаём ясность: где patient flow протекает, почему это стоит денег и какой следующий шаг нужен для управляемого исправления.

Что не продаём на встрече

Не обещаем заявки, не спорим про рекламу, не уходим в SMM, не составляем полный план внедрения бесплатно и не превращаем разговор в прайс-лист.

Блок	Цель	Итог
Patient Flow Check	Показать 3-5 видимых потерь	Клиент признаёт, что проблема шире рекламы
Мини-Карта потерь	Визуализировать слабые места	Появляется основание для платной диагностики
Индекс пациентопотока	Показать управляемость в цифрах	Разговор переходит из мнений в оценку системы
Следующий шаг	Закрыть на оплату	Карта / Fix / Growth

01 / Цель встречи

Цель встречи - не понравиться клиенту. Цель - изменить рамку мышления собственника: с "нам нужна реклама" на "нам нужно понять, где теряется пациент".

- Показать проблему в patient flow, а не в отдельном инструменте.
- Доказать экспертность через конкретные наблюдения по клинике.
- Не отдать полный план бесплатно, а показать необходимость диагностики.
- Закрыть клиента на Карту потерь, Fix или Growth.
- Понять, подходит ли клиника под ICP и есть ли смысл вести дальше.

Ключевая фраза встречи:

«Сегодня мы не будем продавать вам рекламу или SMM. Мы посмотрим на маршрут пациента: где он видит клинику, где начинает доверять, где должен сделать действие и где может исчезать до записи».

Что должен понять клиент	Как это показать
Проблема может быть не в трафике	Показать потери после первого касания: сайт, мессенджер, звонок, CRM, камбэк.
Пациент проходит маршрут	Разложить путь: увидел - поверил - понял - связался - записался - дошёл - вернулся.
Потери стоят денег	Привязать слабые места к записи, лечению, возврату и выручке.
Нужен платный следующий шаг	Объяснить, что полная Карта требует данных, глубины и времени команды.

02 / Подготовка до встречи

Подготовка решает половину продажи. Нельзя приходить на Patient Flow Check с общими словами. До встречи нужно найти видимые потери и собрать предварительную гипотезу.

Зона проверки	Что смотрим	Что фиксируем
Сайт	Главная, услуги, врачи, цены, формы, мобильная версия	Понятность выбора, действие, доверие, скорость пути до записи
Карты	Яндекс, Google, 2ГИС, рейтинг, фото, ответы, категории	Локальный выбор, доверие, актуальность данных
Отзывы	Тональность, свежесть, ответы, частые претензии	Потери доверия и репутационные риски
Мессенджеры	Наличие, доступность, путь до диалога	Барьеры контакта и скорость ответа
Формы	Запись, звонок, онлайн-заявка, СТА	Сложность действия и возможные потери
Конкуренты	2-3 клиники рядом или в той же категории	Где конкурент выглядит сильнее
Реклама	Видимые объявления, посадочные, офферы	Связка входа с маршрутом пациента

Результат подготовки - не отчёт на 20 страниц. Результат - 3-5 точных наблюдений, которые можно показать на экране и связать с patient flow.

03 / Чек-лист подготовки

Перед встречей диагност или продавец должен заполнить короткую рабочую карту. Без неё встречу проводить нельзя.

- Название клиники, город, район, сегмент, примерный уровень цен.
- Ссылка на сайт и карточки в картах.
- 3 сильных стороны клиники, которые нельзя игнорировать.
- 3-5 видимых потерь: где пациент может сомневаться, не понимать или не действовать.
- 2 конкурента, которые выглядят сильнее в конкретных точках.
- Гипотеза по 7К: какие контуры слабее всего.
- Предварительный диапазон Индекса: критично / средне / сильная база.
- Главный крючок для открытия встречи.
- Предполагаемый следующий шаг: Карта, Fix или Growth.

Показывать можно

Скриншоты открытых точек, видимый путь пациента, примеры конкурентов, 3-5 проблемных мест и предварительную логику 7К.

Не показывать бесплатно

Полный список рекомендаций, готовый план на 30/90 дней, точные ТЗ, структуру нового сайта, скрипты администраторов, детальную CRM-логику.

04 / Структура встречи на 30 минут

30 минут достаточно, если встреча управляется. Нельзя уходить в бесконечный разговор о подрядчиках, рекламе и личных историях.

Минуты	Блок	Что делаем	Цель
0-3	Вход	Коротко подтверждаем контекст и регламент	Забрать управление встречей
3-6	Рамка	Объясняем: смотрим patient flow, а не услуги	Сменить категорию разговора
6-12	Вопросы	Выясняем поток, заявки, запись, CRM, администраторов	Понять реальную боль
12-20	Демонстрация	Показываем 3-5 видимых потерь на экране	Доказать экспертность
20-23	7К	Разкладываем потери по контурам	Показать методологию
23-25	Индекс	Даём предварительную оценку управляемости	Перевести в цифры
25-28	Вывод	Обобщаем, что ограничивает patient flow	Создать необходимость действия
28-30	Закрытие	Предлагаем Карту / Fix / Growth	Получить оплату или следующий конкретный шаг

05 / Скрипт открытия встречи

В начале встречи нужно сразу поставить рамку. Если этого не сделать, клиент начнёт спрашивать про рекламу, сайт и цены, а продавец скатится в обычное агентство.

«Спасибо, что нашли время. Сразу обозначу рамку: сегодня мы не будем разбирать весь маркетинг и не будем продавать вам набор услуг. Мы посмотрим на patient flow - путь пациента от первого касания до записи. Я покажу несколько мест, где человек может теряться, и в конце предложу, какой следующий шаг имеет смысл: полная Карта потерь, быстрый Fix или 90-дневный Growth».

Если клиент пытается сразу спросить “сколько стоит реклама”:

«Рекламу можно обсуждать только после понимания, куда она ведёт пациента. Если система после клика протекает, новый трафик просто увеличит объём потерь. Давайте сначала посмотрим маршрут».

06 / Вопросы владельцу

Вопросы должны выявлять не “интерес к услугам”, а управляемость patient flow. Вопросы задаются коротко, без допроса.

Блок	Вопросы
Клиника	Сколько кресел? Какие ключевые направления? Какой средний чек? Кто принимает решение по развитию?
Поток	Откуда сейчас приходят первичные пациенты? Какие каналы стабильны? Где провалы?
Реклама	Есть ли реклама сейчас? Что считаете результатом? Видите ли записи, а не только заявки?
Заявки	Сколько обращений в месяц? Сколько превращается в запись? Где чаще всего теряются?
Администраторы	Кто отвечает на звонки и сообщения? Есть ли скрипты? Проверяете ли качество ответов?
CRM	Все обращения фиксируются? Есть статусы? Кто смотрит пропущенные и “подумаю”?
Запись	Какая доходимость до первичного приёма? Есть ли неявки? Как возвращаете?
Лечение	Сколько первичных доходит до плана лечения? Где пациенты отваливаются?
Возврат	Есть ли повторные касания по базе? Возвращаете ли незавершённые планы?
Подрядчики	Кто сейчас ведёт сайт, рекламу, карты, CRM? Есть ли единый ответственный за поток?
Ожидания	Что вы хотите понять по итогам встречи? Какая точка сейчас больше всего раздражает?

07 / Что показывать на экране

Демонстрация должна быть конкретной и визуальной. Клиент должен увидеть свою клинику глазами пациента.

- Карточки на картах: рейтинг, фото, отзывы, ответы, категории, актуальность информации.
- Сайт: первый экран, услуги, врачей, цены, СТА, формы, мобильную версию.
- Путь до записи: сколько действий нужно, чтобы оставить заявку или позвонить.
- Отзывы: какие страхи или претензии повторяются, есть ли ответы клиники.
- Конкурентов: где конкурент выглядит понятнее, надёжнее или удобнее.
- Мессенджеры: видимость и простота перехода в диалог.
- Примеры слабых мест: скриншоты с короткими пометками “потеря доверия”, “потеря действия”, “потеря контроля”.

Запрещено на встрече уходить в длинный технический аудит. Один экран - один вывод - связь с потерей patient flow.

08 / Как презентовать 7К

7К нужен не для красивой методологии, а для структурирования боли. Через 7К клиент понимает, что проблема не в одном канале.

Контур 7К	Что объясняем клиенту
Касание	Видит ли пациент клинику там, где ищет решение.
Кредит доверия	Хватает ли доказательств, чтобы пациент поверил клинике.
Конкретика	Понимает ли пациент, почему выбрать именно эту клинику.
Контакт	Легко ли пациенту связаться и сделать первый шаг.
Конверсия	Превращается ли обращение в запись и явку.
Курация	Возвращаются ли те, кто не записался, пропал или отложил лечение.
Контроль	Видит ли собственник цифры и управляет ли системой.

Фраза перехода:

«Я разложу найденные места не как “ошибки сайта”, а по 7 контурам patient flow. Так видно, где именно маршрут пациента слабее всего».

09 / Как презентовать Индекс

Индекс пациентопотока нельзя презентовать как окончательный диагноз без данных клиники. На первой встрече это предварительная оценка управляемости.

Диапазон	Как говорить
0-30	Есть критические потери. Сначала нужна Карта, затем быстрый Fix по самым дорогим утечкам.
31-50	Поток сильно протекает. Часть пациентов интересуется, но система не доводит до записи.
51-70	Есть рабочая база, но отдельные контуры ограничивают рост. Нужен 90-дневный цикл.
71-85	Система неплохая, но есть точки для масштабирования и контроля.
86-100	Сильная система. Работа идёт через оптимизацию данных и масштабирование.

«Это не гарантия выручки и не финальный аудит. Это предварительный индекс управляемости маршрута пациента. Чтобы посчитать точно, нужны данные: обращения, записи, CRM, звонки и текущие процессы».

10 / Как не отдать всё бесплатно

Patient Flow Check должен быть полезным, но неполным. Клиенту надо показать направление, а не выдать готовое внедрение.

Можно отдать	Нельзя отдавать бесплатно
3-5 видимых потерь	Полный список всех ошибок и всех рекомендаций
Предварительную логику 7К	Детальную Карту потерь по всем контурам
Диапазон Индекса	Точный расчет Индекса по внутренним данным
Скриншоты открытых точек	ТЗ для дизайнера, сайта, CRM или администраторов
Один пример быстрой победы	План на 30/90 дней с задачами и ответственными
Рекомендацию следующего шага	Полную стратегию роста patient flow

Фраза ограничения:

«На этой встрече я покажу верхний слой видимых потерь. Полная Карта требует данных, проверки звонков, CRM, маршрута пациента и приоритизации. Это уже отдельный диагностический продукт».

11 / Закрытие на следующий шаг

Закрытие должно быть логичным следствием диагностики. Нельзя резко переходить к «купите пакет». Нужно связать следующий шаг с увиденной потерей.

Следующий шаг	Когда предлагать	Фраза закрытия
Карта потерь	Потери видны, но нужно глубже понять масштаб и приоритеты	«Здесь нельзя угадывать. Следующий логичный шаг - полная Карта потерь: считаем 7К, Индекс и приоритеты внедрения».
Fix	Есть 2-3 очевидные критические утечки, которые мешают записи уже сейчас	«Есть вещи, которые не надо долго обсуждать. Их нужно закрыть быстро, иначе вы продолжите терять пациентов».
Growth	Клиника зрелая, есть бюджет, нужна системная работа на 90 дней	«Тут нужен не разовый фикс, а 90-дневный цикл: критические потери, связка контуров и контроль роста».

12 / Скрипты закрытия

На Карту потерь:

«Сейчас мы увидели только внешний слой. Чтобы принять правильное решение, нужна Карта потерь: пройти 7К, посмотреть данные, оценить Индекс и собрать приоритеты. Стоимость - не за аудит ради аудита, а за управленческую ясность: что чинить первым и почему».

На Fix:

«У вас уже видны критические потери, которые можно закрыть без большого исследования. Я бы предложил стартовый Fix: берём самые дорогие утечки и убираем их в короткий срок, чтобы не продолжать терять обращения».

На Growth:

«Если цель - не точечная правка, а управляемый рост, нужна работа циклами. 90 дней - это достаточный срок, чтобы закрыть критические потери, связать контуры и начать видеть динамику patient flow».

13 / Возражения на встрече

Возражение	Что отвечать
Дорого	«Дорого или нет можно понять только рядом со стоимостью потерь. Если пациенты теряются после интереса, клиника уже платит за это каждый месяц».
Надо подумать	«О чём именно нужно подумать: о самой проблеме, следующем шаге или формате? Давайте зафиксируем, что уже понятно и какой шаг минимально безопасный».
Пришлите информацию	«Отправлю резюме, но важно: документ не заменит диагностику. В нём будет только то, что мы увидели сверху, и предложение следующего шага».
Есть маркетолог	«Отлично. Вопрос не в том, есть ли маркетолог, а есть ли единая система patient flow между рекламой, сайтом, администратором и CRM».
Нужна реклама	«Возможно. Но сначала нужно понять, выдержит ли система новый поток. Иначе реклама просто приведёт больше людей в те же потери».
Мы сами исправим	«Часть быстрых вещей - да. Но без карты приоритетов легко исправить видимое и пропустить дорогие потери в обработке, возврате и контроле».

14 / Что делать после встречи

После встречи нельзя исчезать. Первые 24 часа решают, станет ли интерес оплатой.

Срок	Действие	Цель
0-1 час	Заполнить CRM: боль, 7K, интерес, следующий шаг, риски	Не потерять контекст
До 3 часов	Отправить короткое резюме встречи	Закрепить найденные потери
До 24 часов	Отправить предложение: Карта / Fix / Growth	Перевести в оплату
День 2	Follow-up с одним сильным выводом	Вернуть к стоимости потерь
День 4	Уточнить решение и барьер	Не дать уйти в “подумаем”
День 7	Финальное касание по текущему окну	Закрыть или поставить дату возврата

Шаблон письма после встречи:

«Спасибо за встречу. Коротко фиксирую главное: мы увидели несколько зон, где пациент может теряться до записи: [1], [2], [3]. Предварительно слабые контуры - [7K]. Следующий логичный шаг - [Карта / Fix / Growth], чтобы не гадать и понять, что чинить первым. Предлагаю закрепить решение до [дата]».

15 / CRM после встречи

CRM должна фиксировать не только статус сделки, но и диагноз. Иначе следующий контакт будет слабым.

Поле CRM	Что фиксировать
Статус	Встреча проведена / Карта предложена / Fix / Growth / отказ / отложено
Главная боль	Что собственник признал как проблему
Слабые 7K	1-3 контура, которые выглядят ограничителями
Видимые потери	Коротко: карты, сайт, отзывы, контакт, обработка, CRM
Бюджет	Есть / нет / не озвучен / сопротивление
ЛПР	Кто принимает решение и кто влияет

Поле CRM	Что фиксировать
Следующий шаг	Что отправить, когда созвониться, какой дедлайн
Риск сделки	Дорого, думает, есть подрядчик, нет времени, хочет рекламу

16 / KPI консультации

Качество встречи измеряется не длительностью и не “приятным разговором”. Она должна двигать сделку.

Показатель	Норма	Что значит провал
Подготовка	3-5 видимых потерь до встречи	Продавец говорит общими словами
Удержание рамки	Разговор про patient flow	Клиент увёл в рекламу или SMM
Демонстрация	Мини-Карта показана на экране	Нет визуальных доказательств
Квалификация	Понятны бюджет, ЛПР, боль, готовность	Нельзя понять, стоит ли вести дальше
Следующий шаг	Есть конкретное предложение и дедлайн	Закончили “на связи”
Конверсия	Встреча → Карта/Fix/Growth	Встречи не приводят к оплате

17 / Ошибки консультанта

- Начал встречу с рассказа об агентстве, а не с рамки patient flow.
- Принял запрос “нам нужна реклама” как истину, а не как симптом.
- Показал слишком много и отдал план бесплатно.
- Не связал найденную проблему с записью, лечением, возвратом или выручкой.
- Говорил техническим языком вместо языка собственника.
- Не задал вопросы про CRM, администраторов, доходимость и возврат.
- Не предложил следующий шаг с ценностью и дедлайном.
- Отправил “КП на услуги” вместо резюме потерь и предложения платного этапа.

Стандарт: каждая встреча должна закончиться одним из трёх решений - Карта, Fix, Growth или осознанный отказ по ICP.

18 / Финальный стандарт встречи

Patient Flow Check считается проведённым качественно, если клиент понял 5 вещей:

- Проблема может быть не в количестве заявок, а в потерях patient flow.
- Стоматология теряет пациентов в конкретных точках маршрута.
- ШАРiК digital видит эти точки через методологию 7К и Индекс.
- Бесплатная встреча показывает верхний слой, но не заменяет Карту потерь.
- Следующий шаг нужен не для “маркетинга”, а для управляемого устранения потерь.

Финальная формула:

«Мы не продаём консультацию. Мы создаём момент ясности, в котором собственник видит: patient flow протекает, потери стоят денег, а следующий шаг должен быть диагностическим или внедренческим, а не хаотичной покупкой ещё одного digital-инструмента».